БОНУС 1

Банка от 200 заключения на описанието

200 готови изречения за „Заключение / Впечатление“, подредени по модалност и система: за нормално изследване, инцидентална находка и спешна находка. Завършете описанието си с едно ясно изречение, от което читателят знае какво да направи.

Съдържание

Как се пише заключението на описанието

Рентгенография — 50 изречения

КТ — 70 изречения

ЯМР — 35 изречения

Ехография / Doppler — 45 изречения

Следваща стъпка

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Как се пише заключението на описанието

Стъпка ОБОБЩЕТЕ: отговор на клиничния въпрос, най-важната находка на първо място, при нужда препоръка и съобщаване.

> *Повечето клиницисти първо четат раздела „Заключение“. Колкото и добри да са находките, ако заключението е неясно, описанието остава непълно.*

1. **Първо отговорете на клиничния въпрос** — ако въпросът е бил „апендицит?“, първото изречение трябва да казва дали има апендицит, или не.
2. **Подреждайте по важност** — спешната находка винаги е на първо място; инцидентални находки — най-накрая.
3. **Не повтаряйте находките, тълкувайте ги** — Заключението не е копие на находките, а тяхното значение.
4. **Пишете препоръката конкретно** — вместо „препоръчва се допълнително изследване“ посочете кое изследване и защо.
5. **При спешна находка документирайте съобщаването** — на кого, в колко часа и по какъв начин е съобщено.

Видове изречения

ЕТИКЕТ	КОГА	В ТАЗИ БАНКА
НОРМАЛНА	Без патология или без промяна; ограничения на оценката.	43 изречения
НАХОДКА	Рутинни находки, свързани с клиничния въпрос.	82 изречения
ИНЦИДЕНТАЛНА	Случайна находка; с препоръка за обща корелация или проследяване.	26 изречения
СПЕШНА	Находка, която трябва да се съобщи незабавно; с документиране на съобщаването.	49 изречения

За интервалите на проследяване

В изреченията за инцидентални находки не са дадени интервали на проследяване или прагове за размер. Проследяването на възли, надбъбречни лезии, кисти и подобни находки се определя според рисковия профил на пациента и актуалните препоръки, приети във Вашата институция; не пишете в описанието число, в което не сте сигурни — попитайте Вашия ръководител.

Квадратни скоби

[десен/ляв], [.. mm], [час] и подобни полета попълнете, а неподходящите варианти изтрийте. В описанието не бива да остават квадратни скоби.

РАЗДЕЛ 1

Рентгенография

50 заключения, подредени по системи.

Рентгенография · Гръден кош

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
001	На рентгенографията на гръдния кош не се установява остра кардиопулмонална патология.	НОРМАЛНА
002	В сравнение с предходното изследване без съществена промяна.	НОРМАЛНА
003	На рентгенографията на легло не се установяват новопоявили се засенчвания, излив или пневмоторакс.	НОРМАЛНА
004	Тръбите и катетрите са в правилна позиция; не се установяват усложнения, свързани с интервенцията.	НОРМАЛНА
005	[Вдясно/Вляво] [лоб] консолидация; в клиничен контекст може да съответства на пневмония.	НАХОДКА
006	В сравнение с предходното изследване [дясна долна зона] – значителна регресия на консолидацията.	НАХОДКА
007	В сравнение с предходното изследване [дясна долна зона] – нарастване на консолидацията; препоръчва се клинична корелация.	НАХОДКА
008	[Вдясно/Вляво] [малко/умерено/голямо] количество плеврален излив.	НАХОДКА
009	Двустранно малко количество плеврален излив и базална пасивна ателектаза.	НАХОДКА
010	[Вдясно/Вляво] [лоб] ателектаза; при нужда се препоръчва КТ с оглед на централна обструктивна причина.	НАХОДКА
011	Базално линеарни (плочковидни) ателектази.	НАХОДКА
012	Кардиомегалия (на РА рентгенография).	НАХОДКА
013	Поради АР проекцията оценката на размера на сърцето е ограничена.	НАХОДКА
014	Находки в полза на белодробен оток; препоръчва се клинична корелация.	НАХОДКА
015	Белези на белодробна венозна конгестия.	НАХОДКА
016	В сравнение с предходното изследване – регресия на белезите на белодробен оток.	НАХОДКА
017	[Вдясно/Вляво] бял дроб, [зона]: [.. mm] обемна лезия; препоръчва се КТ на гръден кош с контраст.	НАХОДКА
018	[Вдясно/Вляво] [зона]: кавитарна лезия; препоръчва се клинична корелация и КТ с оглед на инфекциозни процеси и неоплазма.	НАХОДКА

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
019	Двустранно дифузни милиметрови нодуларни засенчвания (милиарен образ); препоръчва се клинична и микробиологична корелация.	НАХОДКА
020	Белези на хиперинфлация; може да съответстват на ХОББ.	НАХОДКА
021	[Вдясно/Вляво] [..]. ребро – фрактура; не се установява пневмоторакс.	НАХОДКА
022	Върхът на ендотрахеалната тръба е на [.. cm] над карината, в правилна позиция.	НАХОДКА
023	Върхът на централния венозен катетър е в проекция на горната празна вена; не се установява пневмоторакс.	НАХОДКА
024	[Вдясно/Вляво] [зона]: [.. mm] нодуларно засенчване; за характеризиране се препоръчва клинична корелация и при нужда КТ.	ИНЦИДЕНТАЛНА
025	Калцирани атероматозни промени в аортата.	ИНЦИДЕНТАЛНА
026	[Вдясно/Вляво] пневмоторакс. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
027	[Вдясно/Вляво] обширен пневмоторакс с рентгенологични белези на тензия. Спешна находка; [час] — съобщено по телефона.	СПЕШНА
028	Върхът на ендотрахеалната тръба: [десен главен бронх] – проекция. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
029	Върхът на назогастралната сонда: [десен главен бронх] – проекция, не е в правилна позиция; преди употреба: [час] — съобщено.	СПЕШНА
030	Значително разширение на медиастинума; при травма или болка в гърдите се препоръчва спешна КТ ангиография с оглед на аортна патология. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

Рентгенография · Корем

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
031	На обзорната рентгенография на корема не се установяват белези на обструкция или свободен газ.	НОРМАЛНА
032	Разпределението на чревните газове е нормално.	НОРМАЛНА
033	Находки, съответстващи на тънкочревна обструкция; препоръчва се КТ на корема с контраст.	НАХОДКА
034	Изразено фекално съдържимо в колона.	НАХОДКА
035	[Вдясно/Вляво] [локализация] – плътност в проекцията, която може да съответства на рентгеноконтрастен конкремент; препоръчва се корелация с ехография или КТ без контраст.	НАХОДКА
036	Калцирани плътности в малкия таз, които може да съответстват на флеболити.	ИНЦИДЕНТАЛНА
037	Свободен газ под диафрагмата (пневмоперитонеум). Спешна находка; клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
038	Находки в полза на волвулус на сигмата. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА

Рентгенография · Мускулно-скелетна система

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
039	[Вдясно/Вляво] [област]: не се установява остра костна патология.	НОРМАЛНА
040	Без фрактура или луксация; ставните пролуки са запазени.	НОРМАЛНА
041	Не се установява фрактурна линия; при продължаващо клинично подозрение окултна фрактура не може да се изключи с рентгенография.	НОРМАЛНА
042	[Вдясно/Вляво] фрактура на дисталния радиус ([вътреставна/извънставна], [дорзална] ангулация).	НАХОДКА
043	[Вдясно/Вляво] скафоидна кост, [талия] – фрактура.	НАХОДКА
044	[Вдясно/Вляво] [предна] гленохумерална луксация; препоръчва се контролна рентгенография след репозиция.	НАХОДКА
045	[Вдясно/Вляво] [латерален малеол] – фрактура; глезенна вилка [запазена/разширена].	НАХОДКА
046	Положение на фрактурните фрагменти след репозиция: [приемливо/нарушено].	НАХОДКА
047	[Вдясно/Вляво] коляно: дегенеративни промени (остеоартроза); без остра костна патология.	НАХОДКА
048	Симптом на задната мастна възглавничка; препоръчва се ортопедична оценка с оглед на окултна фрактура.	НАХОДКА
049	[Кост]: [.. mm] литична лезия; за характеризиране се препоръчва клинична корелация и допълнително изследване.	ИНЦИДЕНТАЛНА
050	[Вдясно/Вляво] фрактура на шийката на бедрената кост ([с разместване/без разместване]). Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА

РАЗДЕЛ 2

КТ

70 заключения, подредени по системи.

КТ · Неврорадиология

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
051	На КТ на главния мозък без контраст не се установява остра вътречерепна патология.	НОРМАЛНА
052	Не се установяват вътречерепен кръвоизлив, обемен ефект или изместване на средната линия.	НОРМАЛНА
053	Ранният исхемичен инсулт може да не се вижда на КТ без контраст; при продължаващо клинично подозрение може да се обсъди ЯМР с DWI.	НОРМАЛНА
054	В сравнение с предходното изследване не се установява нов кръвоизлив или нарастване на обемния ефект.	НОРМАЛНА
055	Церебрална атрофия, съответстваща на възрастта; не се установява остра патология.	НОРМАЛНА
056	Перивентрикуларни хиподензни зони, които може да съответстват на хронична болест на малките съдове.	НАХОДКА
057	[Вдясно/Вляво] [локализация]: зона на енцефаломалация, съответстваща на хроничен инфаркт.	НАХОДКА
058	[Вдясно/Вляво] [лоб] обемна лезия и вазогенен оток; препоръчва се ЯМР на главния мозък с контраст.	НАХОДКА
059	[Локализация] – находки, съответстващи на синуит.	НАХОДКА
060	[Вдясно/Вляво] [кост] – линейна фрактура; без съпътстващ вътречерепен кръвоизлив.	НАХОДКА
061	[Локализация]: екстрааксиална лезия с калцификати; може да съответства на менингиом, препоръчва се корелация с ЯМР.	ИНЦИДЕНТАЛНА
062	[Локализация]: лезия с плътност на ликвор, която може да съответства на арахноидна киста.	ИНЦИДЕНТАЛНА
063	[Вдясно/Вляво] остър епидурален хематом; [.. mm] изместване на средната линия. Спешна находка; клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
064	[Вдясно/Вляво] остър субдурален хематом; налице е обемен ефект. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
065	Субарахноидален кръвоизлив; препоръчва се КТ ангиография с оглед на аневризма. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
066	[Вдясно/Вляво] [локализация] остър интрапаренхимен хематом, пробив във вентрикулите: [има/няма]. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
067	[Вдясно/Вляво] Белези на ранна остра исхемия в басейна на MCA; без кръвоизлив. По инсултния протокол: [час] — съобщено.	СПЕШНА
068	[Вдясно/Вляво] Симптом на хиперденсна артерия в MCA; може да е в полза на остър тромб, препоръчва се КТ ангиография. [Час] — съобщено.	СПЕШНА
069	Находки в полза на остра обструктивна хидроцефалия. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
070	[Субфалксна/Транстенториална/Тонзиларна] херниация – радиологични белези. Спешна находка; [час] — съобщено.	СПЕШНА
071	[Вдясно/Вляво] [кост] – импресионна фрактура и под нея [екстрааксиален кръвоизлив]. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
072	На КТ ангиография: [десен/ляв] [MCA M1] сегмент: оклузия. По инсултния протокол: [час] — съобщено.	СПЕШНА

КТ · Гръден кош

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
073	На КТ на гръдния кош не се установява значима патология.	НОРМАЛНА
074	На КТ белодробна ангиография не се установява белодробна тромбоемболия.	НОРМАЛНА
075	Поради недостатъчна опацификация на белодробните артерии оценката на субсегментно ниво е ограничена.	НОРМАЛНА
076	[Вдясно/Вляво] [лоб] консолидация; може да съответства на инфекциозен процес.	НАХОДКА
077	Двустранни зони на матово стъкло; в диференциалната диагноза влизат инфекциозни и възпалителни процеси, препоръчва се клинична корелация.	НАХОДКА
078	[Центрилобуларен] емфизем.	НАХОДКА
079	Лимфни възли с патологичен размер в медиастинума; трябва да се оценят в клиничния контекст.	НАХОДКА
080	[Вдясно/Вляво] бял дроб: [.. mm] обемна лезия и [хиларна/медиастинална] лимфаденопатия; препоръчва се клинична оценка с оглед на тъканна диагноза.	НАХОДКА
081	[Вдясно/Вляво] [лоб]: [.. mm] [солиден] възел; необходимостта от проследяване се определя съвместно с клиничния екип според рисковия профил и актуалните препоръки.	ИНЦИДЕНТАЛНА
082	Калцификати в коронарните артерии.	ИНЦИДЕНТАЛНА
083	Щитовидна жлеза, [десен/ляв] лоб: хиподенсен възел; препоръчва се оценка с ехография.	ИНЦИДЕНТАЛНА
084	[Двустранно] остра белодробна тромбоемболия; белези на обременяване на дясната камера: [има/няма]. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
085	[Ангажираща/Неангажираща възходящата аорта] дисекация на аортата. Спешна находка; клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
086	[Вдясно/Вляво] пневмоторакс. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
087	Пневмомедиастинум; при клинично подозрение за перфорация на хранопровода се препоръчва допълнителна оценка. [Час] — съобщено.	СПЕШНА
088	[Умерено/Голямо] количество перикарден излив; препоръчва се спешна клинична и ехокардиографска оценка с оглед на тампонада. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

КТ · Корем и малък таз

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
089	На КТ на корема и малкия таз не се установява остра патология.	НОРМАЛНА
090	Апендиксът е с нормален вид; не се установяват белези на остър апендицит.	НОРМАЛНА
091	На КТ без контраст не се установяват конкременти в пикочната система или хидронефроза.	НОРМАЛНА
092	В сравнение с предходното изследване [лезия]: без съществена промяна.	НОРМАЛНА
093	[Сигмоиден] колон: остър неусложнен дивертикулит.	НАХОДКА
094	[Вдясно/Вляво] [дистален] уретер: [.. mm] конкремент и [лека] хидроуретеронефроза.	НАХОДКА
095	Белези на остър [интерстициален едематозен] панкреатит.	НАХОДКА
096	Находки в полза на остър холецистит; препоръчва се корелация с ехография.	НАХОДКА
097	Холелитиаза; не се установяват белези на остър холецистит.	НАХОДКА
098	Множество лезии в черния дроб, които може да съответстват на метастази; препоръчва се клинична и при нужда хистопатологична корелация.	НАХОДКА
099	Хепатостеатоза.	НАХОДКА
100	[Малко/Умерено] количество асцит.	НАХОДКА
101	[Локализация] колон: задебеляване на стената; в диференциалната диагноза влизат възпалителни, инфекциозни и неопластични причини, препоръчва се ендоскопска корелация.	НАХОДКА
102	Чернодробен сегмент [..]: лезия, съответстваща на проста киста.	ИНЦИДЕНТАЛНА
103	[Вдясно/Вляво] бъбрек: лезия, съответстваща на проста киста.	ИНЦИДЕНТАЛНА
104	[Вдясно/Вляво] надбъбречен възел; характеризирането и проследяването се определят съвместно с клиничния екип според актуалните препоръки.	ИНЦИДЕНТАЛНА
105	[Вдясно/Вляво] бъбрек: [.. mm] лезия, неуточнима при това изследване; за допълнителна оценка се препоръчва [динамична КТ/ЯМР].	ИНЦИДЕНТАЛНА

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
106	В черния дроб неуточнима при това изследване [.. mm] хиподенсна лезия; при нужда се препоръчва оценка с динамичен ЯМР.	ИНЦИДЕНТАЛНА
107	Находки, съответстващи на остър апендицит. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
108	Белези на остър апендицит и [периапендикулерен абсцес/перфорация] . [Час] — съобщено.	СПЕШНА
109	Пневмоперитонеум; [Възможна локализация] – в полза на перфорация. Спешна находка; [час] — съобщено.	СПЕШНА
110	Преходна зона [област]: находки в полза на механична тънкочревна обструкция и исхемия. [Час] — съобщено.	СПЕШНА
111	Аневризма на коремната аорта и периаортен хематом в полза на руптура. Спешна находка; [час] — съобщено.	СПЕШНА
112	Увреждане на слезката, хемоперитонеум и активна екстравазация на контрастно вещество. [Час] — съобщено.	СПЕШНА
113	Пневматоза на чревната стена и газ в порталната вена; препоръчва се спешна клинична оценка с оглед на мезентериална исхемия. [Час] — съобщено.	СПЕШНА
114	[Вдясно/Вляво] обструктивен уретерен конкремент и [перинефрална колекция/емфизематозни промени]; при клинично подозрение за инфектирана обструкция се препоръчва спешна оценка. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

КТ · Гръбначен стълб и мускулно-скелетна система

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
115	На КТ на шийния отдел на гръбначния стълб не се установява остра травматична костна патология.	НОРМАЛНА
116	Лигаментарно увреждане не може да се изключи напълно с КТ; при неврологична симптоматика се препоръчва ЯМР.	НОРМАЛНА
117	[L1] прешлен: компресионна фрактура с остър вид; не се установява стесняване на гръбначния канал.	НАХОДКА
118	Дегенеративни промени в лумбалните прешлени.	НАХОДКА
119	[Прешлен] – тяло: склеротично огнище; може да съответства на костен остров, препоръчва се клинична корелация.	ИНЦИДЕНТАЛНА
120	[Ниво] – фрактура/луксация с нестабилен вид и стесняване на гръбначния канал. Спешна находка; [час] — съобщено.	СПЕШНА

РАЗДЕЛ 3

ЯМР

35 заключения, подредени по системи.

ЯМР · Неврорадиология

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
121	На ЯМР на главния мозък не се установява значима патология.	НОРМАЛНА
122	На DWI не се установява рестрикция на дифузията в полза на остър инфаркт.	НОРМАЛНА
123	След контраст не се установява патологично контрастиране.	НОРМАЛНА
124	В сравнение с предходното изследване не се установяват нови или контрастиращи се лезии.	НОРМАЛНА
125	Промени в бялото мозъчно вещество, които може да съответстват на хронична болест на малките съдове; без остър инфаркт.	НАХОДКА
126	Лезии в бялото мозъчно вещество, които може да съответстват на демиелинизиращо заболяване; трябва да се оценят спрямо клиниката и актуалните диагностични критерии.	НАХОДКА
127	[Област]: екстрааксиална формация, съответстваща на менингиом.	НАХОДКА
128	Лезия на хипофизата, съответстваща на [микро/макро]аденом; препоръчва се ендокринологична корелация.	НАХОДКА
129	[Вдясно/Вляво] [лоб] пръстеновидно контрастираща се интрааксиална формация; в диференциалната диагноза на първо място се обсъждат глиален тумор с висока степен и метастаза.	НАХОДКА
130	Кистозна лезия, която може да съответства на пинеална киста.	ИНЦИДЕНТАЛНА
131	[Локализация]: образ, съответстващ на венозна аномалия на развитието.	ИНЦИДЕНТАЛНА
132	[Вдясно/Вляво] [артерия] – остър инфаркт в съдовия басейн. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
133	Находки, съответстващи на мозъчен абсцес. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
134	[Синус] – тромбоза. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
135	Остра хеморагия в лезия на хипофизата и компресия на оптичната хиазма; препоръчва се спешна клинична оценка с оглед на апоплексия. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

ЯМР · Гръбначен стълб

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
136	На ЯМР на лумбалния отдел не се установява значима патология.	НОРМАЛНА
137	Освен дискова дегенерация не се установяват белези на значима компресия.	НОРМАЛНА
138	L [4-5] [дясна парамедианна] дискова екструзия; [L5] корен: компресия.	НАХОДКА
139	С [5-6] комплекс диск–остеофит и [дясна] фораминална стеноза; без сигнални промени в гръбначния мозък.	НАХОДКА
140	[L1] прешлен: [остра/подостра] компресионна фрактура; не се установяват белези в полза на патологична фрактура.	НАХОДКА
141	[Прешлен] – тяло: лезия, съответстваща на типичен хемангиом.	ИНЦИДЕНТАЛНА
142	[Ниво] – лезия, която може да съответства на епидурално туморно разпространение, и компресия на гръбначния мозък. [Час] — съобщено.	СПЕШНА
143	[Ниво] – голяма дискова екструзия и изразена компресия на корените на cauda equina; препоръчва се спешна оценка заедно с клиниката. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

ЯМР · Мускулно-скелетна система

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
144	[Вдясно/Вляво] коляно – ЯМР: не се установява значима патология.	НОРМАЛНА
145	[Пълнослойно] разкъсване на ПКВ и [латерален компартимент] – костни контузии.	НАХОДКА
146	[Медиален] менискус, [заден рог] [косо] разкъсване.	НАХОДКА
147	Сухожилие на m. supraspinatus: [пълнослойно] разкъсване; ретракция [.. mm].	НАХОДКА
148	[Вдясно/Вляво] аваскуларна некроза на главата на бедрената кост; без колапс на ставната повърхност.	НАХОДКА
149	Поплитеална (Бейкерова) киста; без белези на руптура.	НАХОДКА
150	[Област]: ангажиране на костния мозък и [субпериостална/мекотъканна] колекция; препоръчва се спешна клинична оценка с оглед на остеомиелит и абсцес. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

ЯМР · Корем и малък таз

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
151	На динамичен ЯМР на черния дроб не се установява огнищна лезия.	НОРМАЛНА
152	Чернодробен сегмент [..]: лезия, съответстваща на типичен хемангиом.	НАХОДКА
153	Конкремент в дисталния холедох (холедохолитиаза) и дилатация на жлъчните пътища.	НАХОДКА

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
154	[Вдясно/Вляво] яйчник: лезия, съответстваща на проста киста; необходимостта от проследяване се определя от клиничния екип.	ИНЦИДЕНТАЛНА
155	В панкреаса [.. mm] кистозна лезия; характеризирането и проследяването се определят съвместно с клиничния екип според актуалните препоръки.	ИНЦИДЕНТАЛНА

РАЗДЕЛ 4

Ехография / Doppler

45 заключения, подредени по системи.

Ехография / Doppler · Корем

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
156	На ехография на целия корем не се установява патология.	НОРМАЛНА
157	Жлъчният мехур е с нормален вид; без конкременти или белези на остър холецистит.	НОРМАЛНА
158	Интра- и екстрахепаталните жлъчни пътища не са дилатирани.	НОРМАЛНА
159	Не се установява свободна течност в коремната кухина.	НОРМАЛНА
160	Оценката на панкреаса е ограничена поради чревни газове.	НОРМАЛНА
161	Холелитиаза; не се установяват белези на остър холецистит.	НАХОДКА
162	Утайка в жлъчния мехур (sludge).	НАХОДКА
163	[Лека/Умерена/Изразена] хепатостеатоза – съответстващ образ.	НАХОДКА
164	Груба ехоструктура и нодуларен контур, които може да съответстват на хронично паренхимно заболяване на черния дроб.	НАХОДКА
165	Спленомегалия.	НАХОДКА
166	Дилатация на холедоха; ако причината не е установена, препоръчва се MRCP.	НАХОДКА
167	[Малко/Умерено/Голямо] количество асцит.	НАХОДКА
168	Чернодробен сегмент [..]: хиперехогенна лезия, която може да съответства на хемангиом; според клиничния контекст се препоръчва допълнително изследване.	ИНЦИДЕНТАЛНА
169	В жлъчния мехур [.. mm] полип; необходимостта от проследяване се определя според актуалните препоръки.	ИНЦИДЕНТАЛНА
170	Находки, съответстващи на остър калкулозен холецистит. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
171	Находки, съответстващи на остър апендицит. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
172	[Илеоколична] инвагинация – съответстващи находки. Спешна находка; [час] — съобщено.	СПЕШНА
173	Чернодробен сегмент [..]: лезия, която може да съответства на абсцес. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА

Ехография / Doppler · Урогенитална система и малък таз

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
174	На ехография на пикочната система не се установява патология.	НОРМАЛНА
175	На доплерова ехография на скротума тестикуларният кръвоток е двустранно симетричен; не се установява патология.	НОРМАЛНА
176	[Вдясно/Вляво] [лека/умерена] хидронефроза; [Възможна причина].	НАХОДКА
177	[Вдясно/Вляво] бъбрек: [.. mm] конкремент; без хидронефроза.	НАХОДКА
178	[Вдясно/Вляво] находки, съответстващи на епидидимоорхит; тестикуларният кръвоток е запазен.	НАХОДКА
179	[Вдясно/Вляво] бъбрек: проста кортикална киста.	ИНЦИДЕНТАЛНА
180	Простата [увеличена]; препоръчва се клинична корелация.	ИНЦИДЕНТАЛНА
181	[Вдясно/Вляво] находки, съответстващи на торзия на тестиса. Спешна находка; [час] — съобщено.	СПЕШНА
182	Не се установява маточна бременност; аднексиална формация и свободна течност — находки в полза на извънматочна бременност. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

Ехография / Doppler · Съдове

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
183	[Вдясно/Вляво] долен крайник: не се установява тромбоза на дълбоките вени.	НОРМАЛНА
184	Двустранно в каротидните артерии не се установяват белези на хемодинамично значима стеноза.	НОРМАЛНА
185	[Вдясно/Вляво] [вътрешна каротидна] артерия: атеросклеротична плака; степен на стеноза според критериите на институцията: [степен].	НАХОДКА
186	[Вдясно/Вляво] находки, съответстващи на тромбоза на повърхностна вена; дълбоката венозна система е проходима.	НАХОДКА
187	В сравнение с предходното изследване, в тромба: [реканализация/без промяна].	НАХОДКА
188	Инфраренална коремна аорта: [.. mm] разширение; необходимостта от проследяване се определя съвместно с клиничния екип.	ИНЦИДЕНТАЛНА
189	[Вдясно/Вляво] [феморополитеален] сегмент: остра дълбока венозна тромбоза. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
190	При симптоматичен пациент [.. mm] аневризма на коремната аорта; руптура не може да се изключи с ехография, препоръчва се спешна КТ ангиография. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

Ехография / Doppler · Шия и повърхностни тъкани

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
191	На ехография на щитовидната жлеза не се установява патология.	НОРМАЛНА
192	На шията не се установяват лимфни възли с патологичен вид.	НОРМАЛНА
193	Щитовидна жлеза, [десен лоб]: [.. mm] възел; според рисковата класификация на Вашата институция: [категория].	НАХОДКА
194	Хетерогенна ехоструктура, която може да съответства на дифузно паренхимно заболяване на щитовидната жлеза; препоръчва се корелация с функционалните тестове на щитовидната жлеза.	НАХОДКА
195	[Област]: колекция, съответстваща на мекотъканен абсцес, и белези на околен целулит.	НАХОДКА
196	[Вдясно/Вляво] гърда: лезия, съответстваща на проста киста.	ИНЦИДЕНТАЛНА

Ехография / Doppler · POCUS и eFAST

№	ЗАКЛЮЧЕНИЕ / ВПЕЧАТЛЕНИЕ	ВИД
197	При eFAST не се установяват белези на свободна течност, перикарден излив или пневмоторакс. Отрицателният eFAST не изключва органно увреждане.	НОРМАЛНА
198	Двустранно множество B-линии; съответстват на интерстициален синдром.	НАХОДКА
199	Положителен FAST: [В Морисоновия джоб] свободна течност. Клиничен екип: [час] — съобщено.	СПЕШНА
200	[Вдясно/Вляво] липсва белодробно плъзгане (lung sliding) и се установява белодробна точка (lung point); в полза на пневмоторакс. [Час] — съобщено.	СПЕШНА

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега отворете Бонус 2 · 50-те грешки в описанието, които ръководителят поправя най-често. Научихте се да избирате правилното заключение; сега разпознайте грешките, заради които описанието се връща, и не ги допускайте повече.

За да видите изреченията в цялостно описание, можете да се върнете към **Основен материал · 120 шаблона за готово описание**.